

Espondilitis Anquilosante

1. Introducción y relevancia clínica

La **espondilitis anquilosante (EA)** es una **enfermedad inflamatoria crónica del esqueleto axial**, caracterizada por **sacroileítis y entesitis (inflamación en la inserción tendinosa o ligamentaria)**, que produce **rigidez progresiva de la columna vertebral** y puede llegar a causar **anquilosis total (“columna en bambú”)**.

Pertenece al grupo de las **espondiloartritis seronegativas**, que comparten características clínicas, genéticas e inmunológicas, incluyendo **ausencia de factor reumatoide (FR negativo)** y asociación con el **HLA-B27**.

Afecta predominantemente a **varones jóvenes entre 20 y 40 años**, con una relación hombre:mujer de 3:1. Su prevalencia global es de **0,1–1%**, y en Chile se estima alrededor de **0,3–0,5%** de la población.

Su importancia clínica radica en que es **una causa relevante de dolor lumbar crónico inflamatorio** en adultos jóvenes y puede asociarse a **compromiso ocular (uveítis anterior), intestinal o cardíaco**.

En el **EUNACOM**, este tema aparece con frecuencia, destacando:

- Dolor lumbar inflamatorio (empeora en reposo, mejora con ejercicio).
- Positividad HLA-B27.
- Sacroileítis bilateral.
- Respuesta a AINEs y tratamiento con anti-TNF.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La espondilitis anquilosante es una **enfermedad autoinflamatoria** en la que la **respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T y citocinas** (especialmente **IL-17 e IL-23**) provoca inflamación crónica de las **entesis** (sitios de inserción ligamentosa y tendinosa).

2.1. Bases inmunológicas

- El **HLA-B27** está presente en más del **85–90% de los pacientes** con EA.

- La hipótesis más aceptada indica que el HLA-B27 altera la presentación antigénica, promoviendo **autoinmunidad dirigida contra antígenos del propio cartílago y entesis**.
- Se genera una inflamación persistente con infiltración de linfocitos T y macrófagos, liberación de TNF- α y IL-17, y **formación ósea aberrante**, que lleva a **anquilosis vertebral**.

2.2. Progresión estructural

1. Inflamación inicial en la **articulación sacroilíaca**.
2. Afectación ascendente de la columna lumbar y torácica.
3. Formación de **puentes óseos (sindesmofitos)** entre vértebras.
4. **Fusión vertebral** con pérdida de movilidad y rigidez completa.

2.3. Factores de riesgo

- Sexo masculino.
- Historia familiar de espondiloartritis.
- HLA-B27 positivo.
- Tabaquismo (empeora la progresión estructural).

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones axiales

Dolor lumbar inflamatorio es el síntoma cardinal.

Características típicas:

- Inicio insidioso antes de los 40 años.
- Duración >3 meses.
- Empeora con el reposo y mejora con el movimiento.

- Rigidez matinal prolongada (>30 minutos).
- Despierta al paciente en la segunda mitad de la noche.

Rigidez progresiva de la columna: pérdida de lordosis lumbar, hipercifosis dorsal y limitación de movilidad cervical.

Limitación funcional: dificultad para agacharse, vestirse o girar la cabeza al conducir.

3.2. Manifestaciones periféricas

- **Artritis oligoarticular asimétrica,** predominante en extremidades inferiores (caderas, rodillas).
 - **Entesitis:** dolor en el talón (tendón de Aquiles o fascia plantar).
 - **Dactilitis:** inflamación difusa de un dedo (“dedo en salchicha”).
-

3.3. Manifestaciones extraarticulares

- **Uveítis anterior aguda:** dolor ocular, fotofobia y visión borrosa (en 25–40% de los casos).
 - **Compromiso cardíaco:** aortitis, insuficiencia aórtica, trastornos de conducción.
 - **Compromiso pulmonar:** fibrosis apical bilateral.
 - **Compromiso renal:** amiloidosis secundaria.
-

3.4. Diagnóstico diferencial

1. **Lumbalgia mecánica:** mejora con reposo, no hay rigidez matinal.
2. **Artritis reumatoide:** afecta articulaciones periféricas simétricas, FR y anti-CCP positivos.
3. **Espondiloartritis psoriásica:** lesiones cutáneas, patrón asimétrico.
4. **Espondiloartritis reactiva:** antecedente infeccioso urinario o gastrointestinal.

5. **Fibromialgia:** dolor difuso sin inflamación objetiva ni rigidez matinal prolongada.

Comentario EUNACOM:

El dolor lumbar que mejora con el ejercicio y no con el reposo, en un hombre joven con HLA-B27 positivo y sacroileítis bilateral, es diagnóstico de **espondilitis anquilosante**.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Laboratorio

- **VSG y PCR elevadas** (indicadores de actividad inflamatoria).
 - **HLA-B27 positivo** en 85–90% de los casos.
 - FR y anti-CCP **negativos** (diferencia clave con AR).
 - Anemia de enfermedad crónica en casos avanzados.
-

4.2. Imágenes

- **Radiografía de pelvis:** sacroileítis bilateral (criterio diagnóstico clásico).
 - Borramiento de líneas articulares, erosiones, esclerosis y finalmente anquilosis.
 - **RM de articulaciones sacroilíacas:** detecta inflamación activa (edema óseo) antes de que aparezcan cambios radiográficos.
 - **Radiografía de columna:** sindesmofitos marginales (“columna en bambú”) en etapas avanzadas.
-

4.3. Criterios de clasificación (ASAS 2009)

Diagnóstico de **espondiloartritis axial** si se cumple uno de los siguientes:

1. **Sacroileítis en imágenes + ≥1 característica clínica de espondiloartritis.**

2. **HLA-B27 positivo + ≥ 2 características clínicas:** dolor lumbar inflamatorio, artritis, entesitis, uveítis, dactilitis, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal o historia familiar.
-

5. Tratamiento (según MINSAL 2023, EULAR/ASAS 2022, UpToDate 2024)

El objetivo del tratamiento es **controlar la inflamación, preservar la movilidad y prevenir la anquilosis**.

5.1. Medidas generales

- Educación sobre la naturaleza crónica y la importancia del ejercicio.
 - Suspensión del tabaco.
 - Ejercicio diario de extensión lumbar y natación.
 - Fisioterapia postural.
 - Evitar inmovilización prolongada.
-

5.2. Tratamiento farmacológico

A. Fármacos de primera línea: AINEs

- Son la base del tratamiento inicial.
 - Ejemplos: naproxeno, indometacina, diclofenaco, celecoxib.
 - Deben administrarse de forma continua mientras exista inflamación activa.
 - Alivian dolor y rigidez y pueden disminuir la progresión estructural.
-

B. Corticoides

- **No se recomiendan de rutina**, salvo en artritis periférica severa o brote agudo localizado.

- Pueden usarse infiltraciones locales en entesitis o artritis monoarticular.
-

C. Fármacos modificadores de la enfermedad (DMARDs)

- No efectivos para el compromiso axial.
 - Indicados solo en **formas periféricas** (artritis o entesitis persistente).
 - Fármacos: **sulfasalazina**, **metotrexato** (uso limitado).
-

D. Biológicos

Indicados en pacientes con enfermedad activa a pesar de AINEs:

- **Anti-TNF α** : etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab.
- **Anti-IL17**: secukinumab, ixekizumab (alternativa cuando falla anti-TNF).

Comentario EUNACOM:

Si un paciente joven con dolor lumbar inflamatorio no responde a AINEs, el siguiente paso terapéutico es iniciar un **anti-TNF**.

5.3. Tratamiento quirúrgico

- En casos de anquilosis severa o deformidad incapacitante: osteotomías correctoras o artroplastias de cadera.
-

6. Complicaciones

- **Anquilosis vertebral completa** (“columna en bambú”).
- **Fracturas vertebrales** por rigidez y fragilidad ósea.
- **Uveítis recurrente**.

- **Insuficiencia aórtica o bloqueo auriculoventricular.**
 - **Fibrosis pulmonar apical bilateral.**
 - **Osteoporosis secundaria.**
 - **Compromiso funcional severo** con pérdida de movilidad axial.
-

7. Pronóstico

La espondilitis anquilosante es **crónica y progresiva**, pero su evolución varía según la severidad y respuesta al tratamiento.

Factores de **mal pronóstico**:

- Inicio precoz (<20 años).
- Sexo masculino.
- Alta VSG/PCR persistente.
- HLA-B27 positivo.
- Compromiso de cadera o columna cervical temprana.

Con tratamiento adecuado (AINEs, anti-TNF, fisioterapia), la mayoría logra **buena calidad de vida y funcionalidad laboral**.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. Dolor lumbar inflamatorio que mejora con ejercicio → sospechar espondilitis anquilosante.
2. HLA-B27 positivo + sacroileítis bilateral = diagnóstico altamente probable.
3. El primer tratamiento siempre son los **AINEs** de uso continuo.
4. Si falla AINE → pasar a **anti-TNF**.

5. FR y anti-CCP **negativos** (clave para diferenciar de AR).
6. La **radiografía de pelvis** es el examen inicial.
7. La **uveítis anterior aguda** es la manifestación extraarticular más frecuente.
8. En el **EUNACOM**, las preguntas más comunes son de **diagnóstico clínico y manejo inicial**.

Errores comunes:

- Confundir con lumbalgia mecánica.
 - Solicitar RM de columna antes de radiografía de pelvis.
 - Usar corticoides sistémicos sin indicación.
 - Olvidar fisioterapia postural diaria.
 - No pesquisar uveítis o síntomas oculares.
-

9. Resumen final (6 ideas clave)

1. La **espondilitis anquilosante** es una **espondiloartritis seronegativa** que afecta el esqueleto axial.
2. Cursa con **dolor lumbar inflamatorio** que mejora con el ejercicio y empeora en reposo.
3. Está fuertemente asociada al **HLA-B27** y a **sacroileítis bilateral**.
4. El tratamiento inicial son los **AINEs**, y si no hay respuesta, los **anti-TNF**.
5. FR y anti-CCP son negativos, lo que la diferencia de la artritis reumatoide.
6. En **EUNACOM**, las preguntas se enfocan en la **clínica típica**, el **uso de AINEs** y la **asociación HLA-B27**.